



ห้ามมิให้นักศึกษาทำซ้ำ ดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ปรากฏอยู่ในระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการศึกษาส่วนบุคคล ทั้งนี้ การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และหากเป็นการกระทำการเพื่อการค้า จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Unless allowed by Mahidol University, the User shall not copy, modify, or exploit in part or in whole of the copyrighted materials on the Platform, other than for your own individual study. The copy, modify or communication to public of the copyrighted materials shall be inflicted with a fine from 20,000 Baht up to 200,000 Baht. If the offence is committed with the commercial purpose, the offender shall be inflicted with imprisonment for a term from 6 months up to 4 years or a fine from 100,000 Baht up to 800,000 Baht or both imprisonment and fine.



# การประเมินภาวะจิตใจ อารมณ์ สังคมและ จิตวิญญาณของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด

อ.ดร.ภาศิษฏา อ่อนดี

ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



## วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ภายหลังสิ้นสุดการเรียน นักศึกษาสามารถ

- อธิบายความสำคัญของการประเมินภาวะจิตสังคมของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได้
- อธิบายหลักการและแนวทางในการประเมินภาวะจิตสังคมของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได้
- อธิบายองค์ประกอบของการประเมินภาวะจิตสังคมได้
- ระบุความผิดปกติจากการประเมินภาวะจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได้

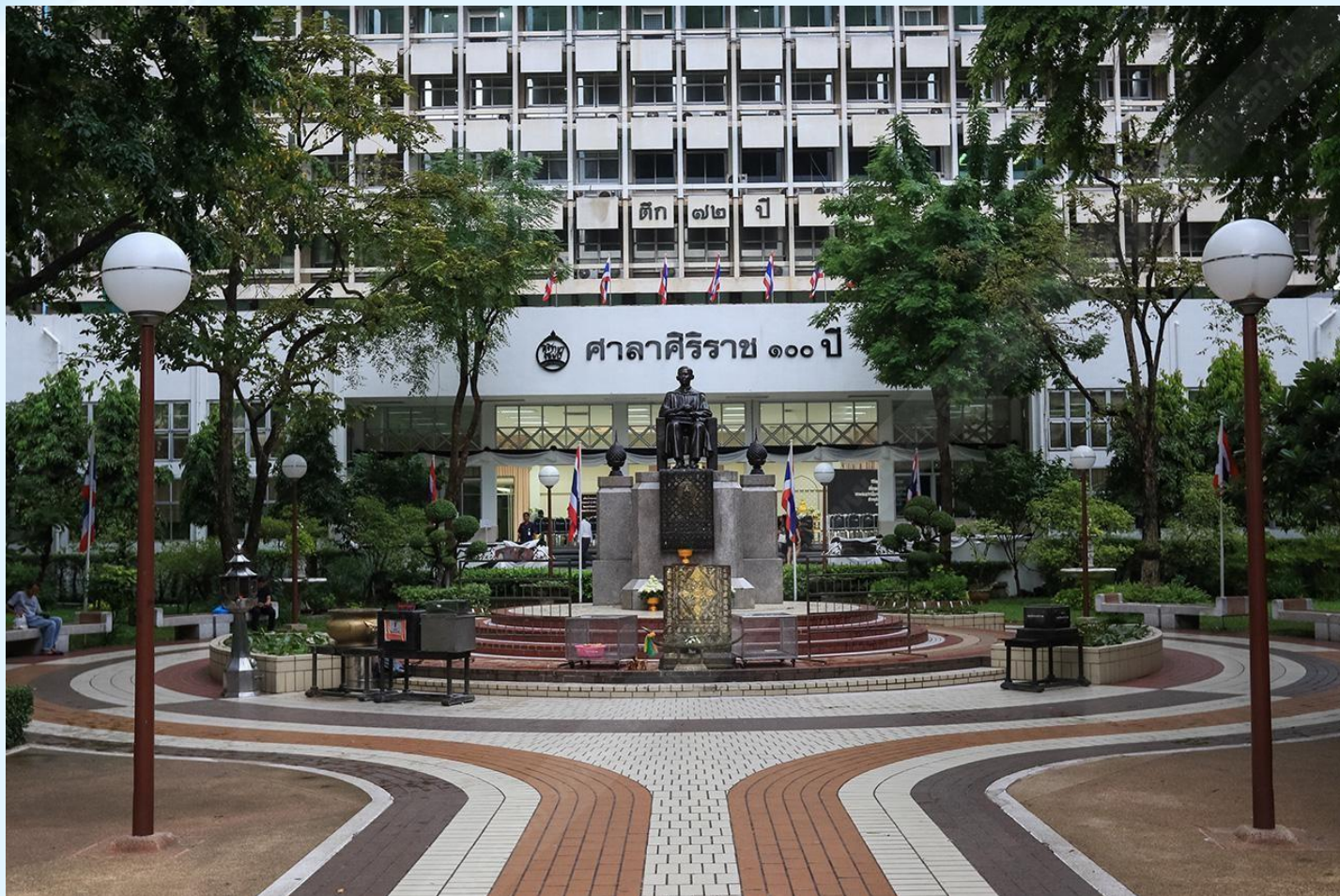


# การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic care)

คือ การดูแลผู้ป่วยครบทุกมิติที่มีผลกระทบต่อความเจ็บป่วย  
ได้แก่ มิติด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ













ภาพการผ่าตัดในช่วง พ.ศ. 2479  
ภาพจากหนังสือที่ระลึกเปิดตึก 72 ปี รพ.ศิริราช



ห้องผ่าตัด รพ ศิริราช ปี 2483







## Outcomeของการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด

1. ผู้ป่วยคลายวิตกกังวลและให้ความร่วมมือในการรักษาและปฏิบัติตัวได้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่
2. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้และความเชื่อมั่นในการรักษา
3. ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง











# ความสำคัญของการประเมินภาวะจิตสังคมของ ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด







- การผ่าตัดเป็นการคุกคามต่อชีวิตและเป็นสถานการณ์วิกฤตของผู้ป่วยที่ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวลแก่ผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก





## ขณะที่ผู้ป่วยต้องนอนรอทำผ่าตัดในห้องรอผ่าตัด

- อาจเกิดความกลัวโดยไม่ทราบสาเหตุ
  - ต้องมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมของห้องผ่าตัดที่แปลกใหม่
  - ต้องแยกจากบุคคลใกล้ชิด
- ทำให้ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น
- ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม ➡ จนกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการผ่าตัดได้



## เมื่อผู้ป่วยก่อนผ่าตัดมีความวิตกกังวล

- ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายที่จะก่อให้เกิดปัญหาในระยะผ่าตัด
  - ทำให้ต้องใช้ยาระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัดเพิ่มขึ้น
  - มีผลต่อการฟื้นตัวจากยาระงับความรู้สึกในระยะหลังผ่าตัด
  - ยังส่งผลถึงการปรับตัวและการฟื้นฟูสภาพระยะหลังผ่าตัด
- ระดับความวิตกกังวลที่สูงขึ้นในระยะก่อนได้รับการผ่าตัดใหญ่จะมีผลกระทบตุนให้ร่างกายปล่อย Catecholamine และฮอร์โมน Corticosteroid เข้าสู่กระแสเลือดมากขึ้น ทำให้อัตราและจังหวะการเต้นของหัวใจและระบบการหายใจผิดปกติ

(พรทิพย์ ศุภมณี และคณะ, 2553)

## เมื่อผู้ป่วยก่อนผ่าตัดมีความวิตกกังวล

- ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดมีผลต่อการหายและการอักเสบของแผลหลังผ่าตัดอีกด้วย เนื่องจากร่างกายได้รับการกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมน Glucocorticoids ออกมามากกว่าปกติ

(นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์, 2553)

- ความวิตกกังวลทำให้ความดันโลหิตสูงขณะและหลังผ่าตัด

(William, J.B.& et.al.(2013).



# เมื่อผู้ป่วยก่อนผ่าตัดมีความวิตกกังวล

- Hypertension is a common clinical condition that may have a large impact on surgical outcomes. (Aronson S.& et.al. (2018). Perioperative cardiac surgery hypertension)
- In one study, 43% of the patients who applied for surgery were found to have HT. In 24.6% of these patients, their surgeries were postponed to ensure BP control. (Akin S.& et.al. (2014). The role of hypertension and diabetes in the delayed operation at preparation for surgery).



# ความคาดหวังของผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด

- ความต้องการข้อมูลก่อนได้รับผ่าตัด
  - ข้อมูลการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัด
  - กิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้หลังผ่าตัด
  - ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม เช่น ความสะอาดของห้องผ่าตัด ความเจ็บสงบภายในห้องผ่าตัด ความนุ่มนวลในการรับส่งผู้ป่วย



## ความคาดหวังของผู้ป่วยก่อนได้รับผ่าตัด

- ความต้องการการดูแลจากพยาบาลห้องผ่าตัดก่อนได้รับการผ่าตัด
  - ความต้องการสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เช่น ต้องการการต้อนรับที่อบอุ่นจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด
  - ต้องการให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดเรียกและพูดคุยด้วยคำพูดที่สุภาพอ่อนโยน
  - ต้องการให้มีคนคอยพูดคุยและให้กำลังใจ





# ความคาดหวังของผู้ป่วยก่อนได้รับผ่าตัด

- ความต้องการด้านจิตวิญญาณ
    - ต้องการให้แพทย์หรือพยาบาลให้ความหวังว่าการผ่าตัดครั้งนี้สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคที่เป็นอยู่
    - ต้องการหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจติดตัวมาขณะรอเข้าห้องผ่าตัด
    - ต้องการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ความเชื่อ โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของ รพ.เช่น ไหว้พระ สวดมนต์ ทำสมาธิ ทำละหมาดขณะรอเข้าห้องผ่าตัด
- (ไมตรี ยอดแก้ว, วีนีกาญจน์ คงสุวรรณ และศรีสุดา วนาลีสิน, 2553; Hobson, Slade, Wrench, & Power, 2006)



## ความคาดหวังของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

- การบริการที่เป็นมิตร
- การดูแลด้วยความเอื้ออาทร
- การได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอ
- ความพร้อมของสิ่งแวดล้อมในการดูแลความปลอดภัย
- การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

ณาทยา โสณน้อย และคณะ (2562) ความคาดหวังของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและผู้ดูแลผู้ป่วย: มุมมองจากการศึกษาเชิงคุณภาพ



“พยาบาลและคุณหมอมองให้การต้อนรับ ยิ้มแย้มเป็นมิตร และให้เวลาในการซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด บอกเราทุกครั้งที่จะให้การรักษาว่ามาโรงพยาบาลนี้ใช้สิทธิ 30 บาทได้ ทำให้เราไม่กังวลเรื่องค่ารักษา”

“ก่อนผ่าตัดผมก็กังวลมาก ความดันขึ้นสูงตั้งแต่เข้าโรงพยาบาล ถามพยาบาลที่มาวัดความดันตลอดเป็นไง ลดหรือยัง ต้องเพิ่มยาไหม พยาบาลก็อดทนมากตอบคำถามทุกครั้งโดยไม่รำคาญ ไม่หน้าบึ้งเลย”



“มืออดอยู่ข้างๆ แต่ไม่มีแรงกด นอนลืมตา อยากให้พยาบาลมาถามอาการ อยากดื่มน้ำ พอทีมพยาบาลเข้ามานะ โอ้โห มาช่วยยกตัว พลิกหมอน รู้สึกสบายขึ้นใจ กลับได้เลยนะ”

“พยาบาลสอนการหายใจก่อนผ่าตัด ตอนแรกคิดว่าไม่น่ายาก แต่หลังผ่าตัดเท่านั้นแหละ แทบไม่อยากขยับตัว พยาบาลก็เมตตามาช่วยกระตุ้นให้ หายใจลึกๆตามขั้นตอน ช่วยให้กำลังใจ บอกว่าจะได้ช่วยให้ปอดขยายตัวดีขึ้น และฟื้นตัวเร็ว”





## ปัญหาด้านจิตใจที่มักพบในผู้ป่วยผ่าตัด

- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด การปฏิบัติตัว สุขภาพหลังผ่าตัด
- ความกลัว: กลัวผ่าตัดไม่สำเร็จ กลัว เสียชีวิต กลัวพิการ กลัวเจ็บ กลัวไม่ฟื้น
- ความทุกข์ทรมานจากแผลผ่าตัด

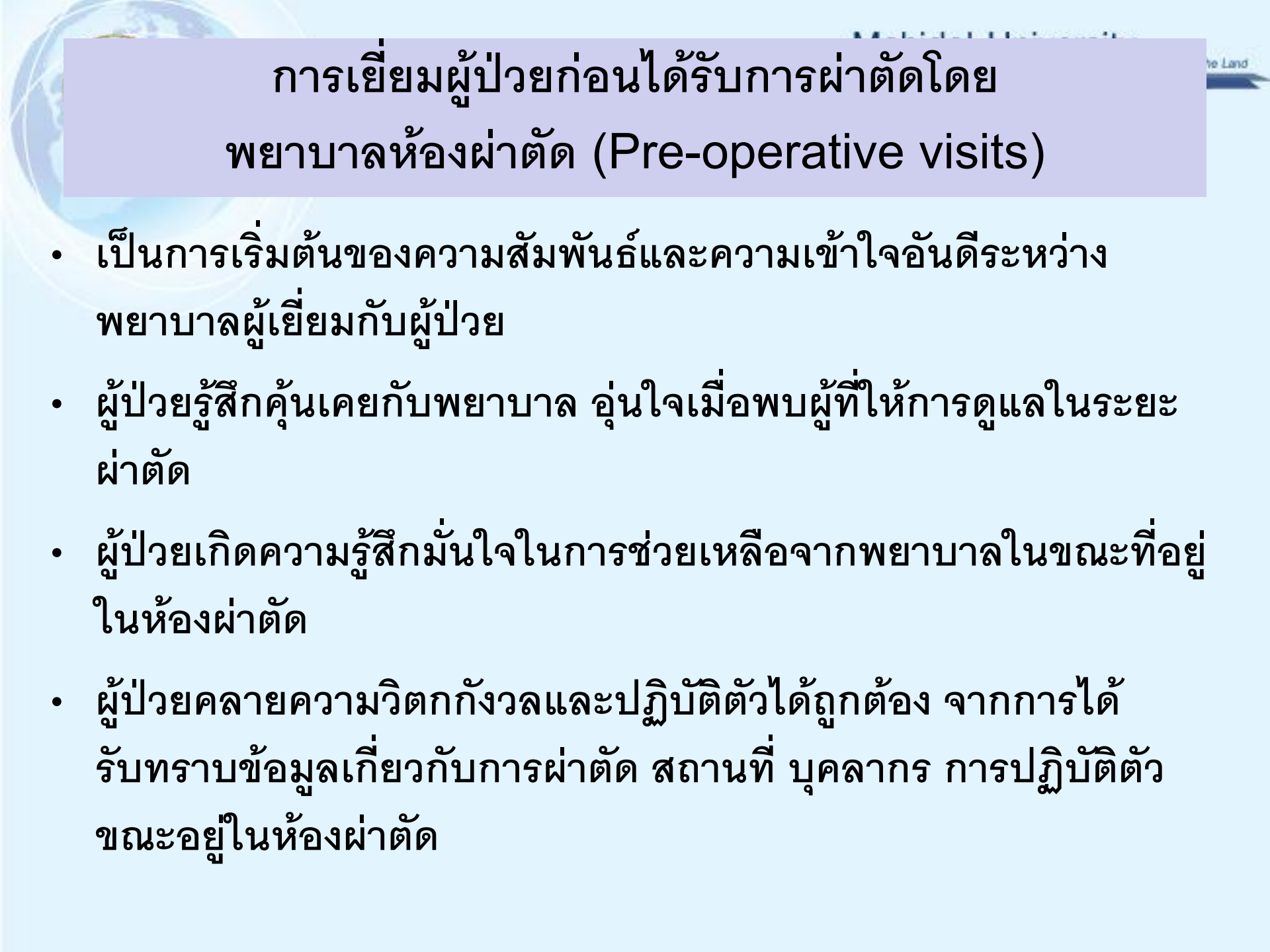




ประสิทธิผลของการเย็บเพื่อให้ความรู้ก่อนผ่าตัดต่อความวิตกกังวลและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดใหญ่ทางนรีเวชโรงพยาบาลศิริราช  
( พรทิพย์ ศุภมณี และคณะ 2554)

### ผลการวิจัย พบว่า

- กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่เป็นมะเร็ง พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการเย็บเพื่อให้ความรู้ก่อนผ่าตัด มีความวิตกกังวลในวันทำผ่าตัดน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการเย็บก่อนผ่าตัด
- กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการเย็บเพื่อให้ความรู้ก่อนผ่าตัด มีความวิตกกังวลในวันทำผ่าตัดน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการเย็บก่อนผ่าตัด
- ผลการเย็บเพื่อให้ความรู้ก่อนผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่เป็นมะเร็ง และเป็นมะเร็ง มีความวิตกกังวลลดลงภายหลังการเย็บทันที และต่อเนื่องจนถึงในวันเข้ารับการผ่าตัด



## การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัดโดย พยาบาลห้องผ่าตัด (Pre-operative visits)

- เป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพยาบาลผู้เยี่ยมกับผู้ป่วย
- ผู้ป่วยรู้สึกคุ้นเคยกับพยาบาล ชื่นใจเมื่อพบผู้ที่ให้การดูแลในระยะผ่าตัด
- ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกมั่นใจในการช่วยเหลือจากพยาบาลในขณะที่อยู่ในห้องผ่าตัด
- ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง จากการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด สถานที่ บุคลากร การปฏิบัติตัวขณะอยู่ในห้องผ่าตัด

# สุดท้าย พยาบาลเข้ากอดคุณยายที่กลัวการผ่าตัด สัญญาจะอยู่ข้างๆ







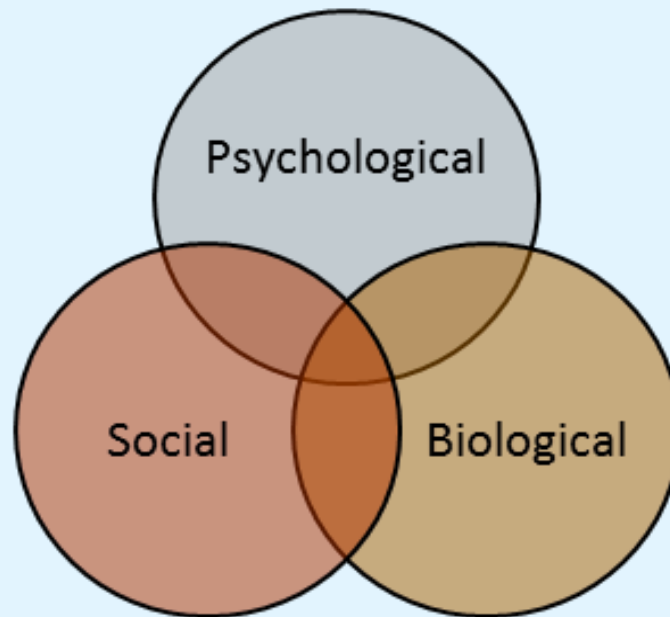
การประเมินภาวะจิตสังคม  
(จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ)  
ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด





# แนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพ

## The Biopsychosocial model



Source: <https://determined2.com.au/what-is-the-biopsychosocial-model>



## การประเมิน (Assessment)

- เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพยาบาล
- เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ครอบครัว
- ข้อมูลเหล่านี้จะครอบคลุมทั้ง จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สังคม และจิตวิญญาณ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนให้การพยาบาล ที่เหมาะสมต่อไป



## ความสำคัญของการประเมินภาวะจิตสังคม

- ทำให้เข้าใจผู้ป่วยแบบองค์รวม
- ประเมินและวิเคราะห์ภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยได้ถูกต้อง
- ทำให้เข้าใจปัญหาทางสุขภาพจิตของผู้ป่วยอย่างถูกต้องและครอบคลุม
- กำหนดข้อวินิจฉัยทางการแพทย์อย่างถูกต้องและครอบคลุม
- วางแผนการพยาบาลและให้การพยาบาลอย่างถูกต้องและครอบคลุม





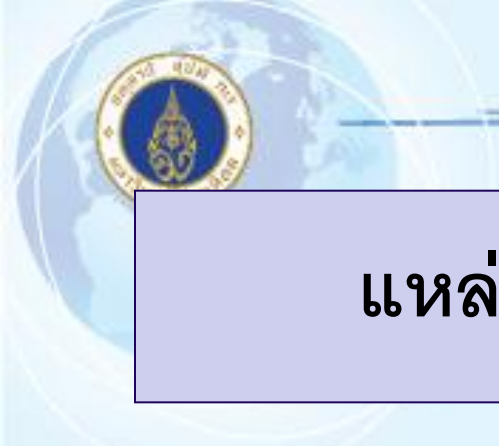
## ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ประเมินภาวะจิตสังคม

- Subjective data: ข้อมูลที่ได้จากการบอกเล่าโดยตรงจากผู้รับการประเมิน
- ได้จากการสอบถามและการสัมภาษณ์ พยาบาลต้องสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้รับการประเมินและใช้เทคนิคที่เหมาะสม



## ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ประเมินภาวะจิตสังคม

- Objective data: ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต จากรายงานของแพทย์ เวชระเบียน และเอกสารอื่นๆ
- เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตผู้ป่วยทั้งขณะสนทนาหรือขณะอื่นเมื่อมีโอกาส เช่น สังเกตลักษณะทั่วไป สีหน้าท่าทาง น้ำเสียง พฤติกรรม การแสดงออก



## แหล่งข้อมูลที่ใช้ประเมินภาวะจิตสังคม

- ผู้ป่วย
- ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด
- บันทึกการซักประวัติและตรวจร่างกายของแพทย์
- บันทึกของบุคลากรในทีมสุขภาพ
- ผลการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ
- ผลการทดสอบทางจิตวิทยา
- บันทึกทางการแพทย์

## วิธีการรวบรวมข้อมูลภาวะจิตสังคม

- การสังเกต (Observation): พฤติกรรมทั่วไป สีหน้า กิริยาท่าทางการเดิน การแต่งกาย เสื้อผ้า ความสะอาดร่างกาย การพูด น้ำเสียง ฯลฯ
- การซักถาม/สัมภาษณ์ (Interviewing) ควรใช้คำถามปลายเปิด (Open-ended questions) เช่น “วันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ”
- การตรวจสภาพจิต (Mental status examination)





## ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินภาวะจิตสังคม

1. ผู้ประเมิน:
  - ขาดทักษะในการประเมิน
  - มีบุคลิกภาพไม่เหมาะสม
2. ผู้ถูกประเมิน:
  - ปัญหาสุขภาพ/ความเจ็บป่วย
  - ความเสื่อมของร่างกายตามวัย
  - ประสบการณ์เดิม



## ทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในการประเมินภาวะจิตสังคม

- ช่างสังเกต (Observation)
- มีทักษะการฟัง (Listening)
- ยอมรับในตัวผู้ป่วย/ผู้รับบริการ (Accepting)
- เข้าใจความรู้สึกผู้ป่วย/ผู้รับบริการ (Empathy)
- เข้าใจบริบท ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ (Understanding)

## ทักษะการฟัง

- เป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างตั้งใจ ติดตามตลอดการสนทนา เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วย
- ให้โอกาสผู้ป่วยพูดจนจบ รอคอยด้วยท่าที่สงบ ให้เวลาผู้ป่วยคิด
- มีการพูดโต้ตอบและกระตุ้นให้ผู้ป่วยพูดในจังหวะที่เหมาะสม
- สรุปและสะท้อน คำพูด ที่ผู้ป่วยพูด เพื่อทบทวนความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย ขณะที่ รับฟังพยาบาลก็สังเกตการพูด กริยา ท่าทาง ได้ด้วย



## ลักษณะของผู้สัมภาษณ์ที่ดี

- ให้เกียรติผู้ป่วย : ไม่แสดงท่าทางวิพากษ์วิจารณ์ ตัดสิน ถูกผิดต่อสิ่งที่ผู้ป่วยเล่า ควรมีท่าทีสนใจ ตั้งใจฟัง ไม่แสดงท่าทางประหลาดใจ มีท่าทีอบอุ่น นุ่มนวล
- สนใจและเข้าใจความรู้สึกผู้ป่วย: มีผลต่อสัมพันธภาพในการสัมภาษณ์

## ลักษณะของผู้สัมภาษณ์ที่ดี (ต่อ)

- มีความจริงใจต่อผู้ป่วย ควรมีท่าทีเปิดเผย เป็นธรรมชาติ ไม่เสแสร้ง คำนึงถึงประโยชน์ผู้ป่วยเป็นหลัก
- ทำให้ผู้ป่วยไว้วางใจว่าเราสามารถช่วยเขาได้: บุคลิกภาพที่เหมาะสมของผู้สัมภาษณ์ มีความสามารถในการซักถาม ปัญหาหรืออาการที่ผู้ป่วยไม่เคยสังเกตมาก่อน มีความสามารถในการสื่อถึงการช่วยเหลืออย่างจริงใจ





## เทคนิคเบื้องต้นในการสัมภาษณ์ผู้ป่วย (Interviewing technique)

- การเริ่มต้นการสัมภาษณ์ (Opening interview)
  - ทักทาย/สร้างความคุ้นเคย ก่อนการสัมภาษณ์จริง เช่น  
“ มารอนานหรือยังคะ” “บ้านอยู่แถวไหนคะ”
  - แนะนำตนเองและขั้นตอน เช่น บอกว่าจะมีเวลาคุยกับ  
ผู้ป่วยนานแค่ไหน
  - ทำที่ผ่อนคลาย ควรนั่งลงคุยกับผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียง  
ควรนั่งบนเก้าอี้เพื่อคุยในระดับเดียวกัน



## เทคนิคเบื้องต้นในการสัมภาษณ์ผู้ป่วย (Interviewing technique)

- เริ่มต้นด้วยประโยคกว้างๆ และแสดงความเข้าใจ (empathy) เช่น วันนี้ดูคุณเครียดๆ มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณ เราจะช่วยเหลื้ออะไรคุณได้บ้าง
- ควรใช้คำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ป่วยได้อธิบายเพิ่มเติม
- หลีกเลียงคำถามนำ หรือคำถามปลายปิด เช่น เมื่อคืนคุณนอนกี่ชั่วโมง คุณนอนหลับสบายใช่หรือไม่



## เทคนิคเบื้องต้นในการสัมภาษณ์ผู้ป่วย (Interviewing technique)

- ใช้คำถามที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้ป่วย
- ใช้คำสุภาพและระมัดระวังคำพูดที่กระทบกระเทือนจิตใจ
- ควรใช้น้ำเสียงและภาษาที่ไม่ตัดสินผู้ป่วย โดยเฉพาะเมื่อถามเรื่องที่จะละเอียดอ่อน เช่น การใช้สารเสพติด การถูกทารุณกรรม
- มีความกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือตามปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยทันทีที่ประเมินปัญหาได้
- ถามผู้ป่วยทีละประเด็นๆ ไม่กระโดดไปกระโดดมา



## เทคนิคเบื้องต้นในการสัมภาษณ์ผู้ป่วย (Interviewing technique)

- ใส่ใจต่อความสุขสบายของผู้ป่วย : ผู้ป่วยนั่งในท่าที่สบาย นั่งในมุมที่เหมาะสม
- จัดสิ่งแวดล้อม : สถานที่สัมภาษณ์ควรมีความเป็นส่วนตัว เงียบสงบ อุณหภูมิไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป บรรยากาศเป็นมิตร
- ให้ความมั่นใจในการเก็บข้อมูลเป็นความลับ (confidentiality)

## แนวทางในการประเมินภาวะจิตสังคมของผู้ป่วย

- แนะนำตัว บอกวัตถุประสงค์ บอกเรื่องการรักษาความลับ
- พูดถึงพฤติกรรมที่เป็นปกติทั่ว ๆ ไปก่อนจะเข้าไปถึงปัญหาสำคัญ
- ระมัดระวังการใช้คำหรือประโยคที่ Sensitive
- ให้ผู้ป่วยช่วยอธิบายประโยคที่ยังคลุมเครือ
- ให้ผู้ป่วยมุ่งพิจารณาปัญหา/ความต้องการที่สำคัญที่สุดก่อน
- ถ้าผู้ป่วยพูดมากเกินไปจนจับประเด็นไม่ได้ พยาบาลอาจจะต้องยับยั้งอย่างเหมาะสม
- แสดงท่าทีที่เข้าใจและยอมรับผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยไม่พูดหรือเงียบไปเฉย ๆ





# การประเมินและวิเคราะห์ภาวะจิตสังคม





## องค์ประกอบของภาวะจิตสังคม

- มิติด้านร่างกาย (Physical Dimension)
- มิติด้านอารมณ์ (Emotional Dimension)
- มิติทางสติปัญญา (Intellectual Dimension)
- มิติด้านสังคม (Social Dimension)
- มิติด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Dimension)



# มิติด้านร่างกาย

## ลักษณะทั่วไปและพฤติกรรม (General appearance)

- การแต่งกาย เสื้อผ้า : เรียบร้อย สีสันดูสะอาด สะอาด
- สีหน้า ท่าทาง (เช่น ท่าท่าแปลกๆ คุกคาม) การสบตา (เช่น หลบตา จ้องมองไปข้างหน้าแบบไร้จุดหมาย)
- การแต่งหน้า/เครื่องประดับ การใช้เครื่องสำอาง
- ความสะอาดร่างกายทั่วไป
- การเคลื่อนไหว: มือสั่น กระตุก เดินผิดปกติ ผุดลุกผุดนั่ง
- คำพูด การสนทนา ปฏิภาณไหวพริบ (แกว่งมือ ตัวสั่น)



## มิติด้านร่างกาย (ต่อ)

- การดำเนินชีวิตประจำวัน (Daily activities)
  - การรับประทานอาหาร
  - การย่อยและการขับถ่าย
  - การพักผ่อนนอนหลับ
  - กิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกาย
  - การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา



## มิติด้านร่างกาย (ต่อ)

- พันธุกรรม (Genetic)
  - ภาวะสติปัญญาบกพร่อง
  - การเจ็บป่วยทางกายและจิตของสมาชิกในครอบครัว
- ประวัติสุขภาพ การเจ็บป่วยในอดีต อุบัติเหตุ
- ประวัติการฆ่าตัวตาย
- ความพิการทางกาย





## ความผิดปกติของลักษณะภายนอก

- **Bizarre appearance** พบในผู้ป่วยโรคจิตเวช เช่น จิตเภท (Schizophrenia), บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorder)
- **Over-bright clothing** พบในผู้ป่วยอารมณ์ครื้นเครงผิดปกติ (Mania)
- **Poorly grooming** พบในผู้ป่วยโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า (Depression)

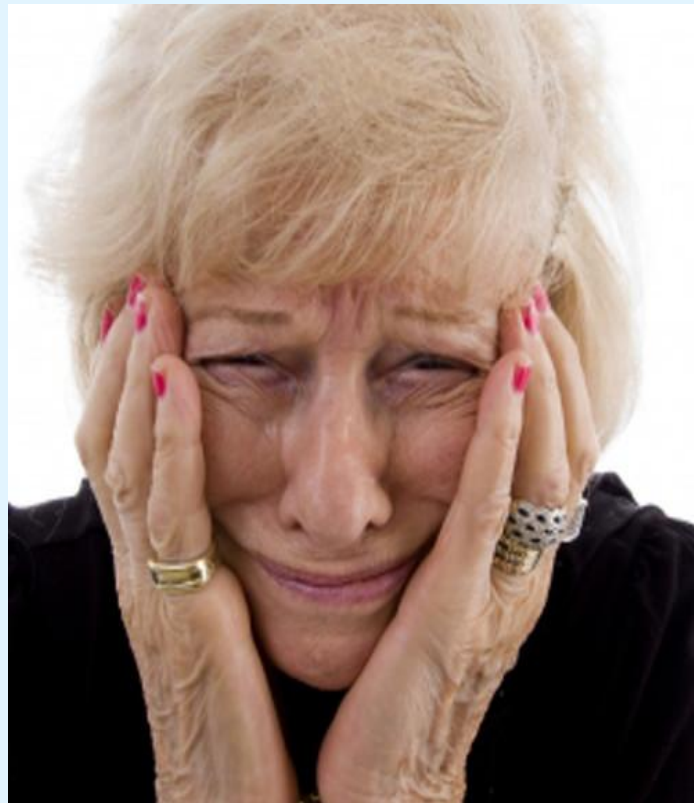


## พฤติกรรมที่ผิดปกติ

- Stereotypic behavior (พฤติกรรมซ้ำ ๆ: โยกตัว)
- Bizarre behavior (พฤติกรรมแปลกประหลาด)
- Aggressive (พฤติกรรมก้าวร้าว)
- Hostile (ทำที่ไม่เป็นมิตร ตาขวาง)



# มิติด้านอารมณ์ (Emotional Dimension)





# มิติด้านอารมณ์

ประเมินจาก

- : สีหน้า ท่าทาง
- : การเคลื่อนไหวร่างกาย
- : คำพูด น้ำเสียง
- : พฤติกรรม



## อารมณ์ (Mood and affect)

- **Mood:** อารมณ์พื้นฐานในขณะที่ไม่มีสิ่งใดมากระตุ้น เช่น neutral (เฉย ๆ), euphoric (สุขมาก) , depressed (ซึมเศร้า), anxious (กังวล), irritability (หงุดหงิด)
- **Affect (Emotion):** อารมณ์ที่แสดงออก เป็นสภาวะของความรู้สึกที่บุคคลรับรู้ที่เกิดจากการถูกกระตุ้น เช่น blunted (ทื่อ), restricted (ไม่ค่อยแสดงอารมณ์), inappropriate (การแสดงอารมณ์ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์)



# อารมณ์

- จากการสังเกต
  - **การแสดงสีหน้า:** ยิ้มแย้ม บึ้งตึง ขมวดคิ้ว ไม่แสดงอารมณ์
  - **การเคลื่อนไหว:** ลุกลี้ลุกลอน ซึมเฉย ท่าทางแปลก
  - **อาการอื่นๆ:** ร้องไห้ มือสั่น ใจสั่น เหงื่อออกมาก
  - มีการแสดงอารมณ์สอดคล้องกับเรื่องที่พูดหรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้อง เรียก **inappropriate affect**
  - **อารมณ์:** เปลี่ยนแปลงง่าย? ระดับอารมณ์คงที่?
  - ความเร็วในการพูด (Speech) เช่น พูดเร็วรัวฟังไม่ทัน





# อารมณ์

- จากการซักถาม
- ประเมินว่าพื้นฐานอารมณ์ผู้ป่วยเป็นอย่างไร เช่น ปกติเป็นคนใจเย็น หรือ โมโหง่าย
- ถามผู้ป่วยว่า ขณะนี้รู้สึกอย่างไร
- ถามผู้ป่วยว่า เวลาโกรธหรือโมโหควบคุมอารมณ์ได้หรือไม่



# มิติทางด้านสติปัญญา (intellectual dimension)



## มิติด้านสติปัญญา

1. ความคิด
2. การรับรู้
3. ระดับการรู้ลึกทั่ว
4. การรับรู้ เวลา สถานที่  
บุคคล
5. ความรู้ทั่วไป
6. การตัดสินใจ
7. การรู้จักตนเอง
8. ความคิดเชิงนามธรรม
9. ความสนใจ/สมาธิ
10. ความจำ



## ความคิด (Thought)

- Thought content (เนื้อหาความคิด):

ถ้าผิดปกติ เรียกว่า ความคิดหลงผิด (Delusion) เป็นความเชื่อผิด ๆ ที่ไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

-grandeur delusion : คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่

-persecutory delusion: คิดว่ามีคนปองร้าย

-jealousy delusion : คิดว่าสามี/ภรรยามีชู้

-idea of reference : คิดว่าทีวีหรือวิทยุพูดเรื่องของตนเอง



## ความคิด (Thought)

- Thought form (รูปแบบความคิด):
  - loosening of association: พบในโรคจิตเภท
  - **flight of idea**: พบในโรคอารมณ์ครึ้นเครงผิดปกติ
  - blocking: พุด ๆ แล้วหยุดไปเฉย ๆ
  - **circumstantial**: พุดอ้อมแล้วจึงกลับมาตอบคำถาม
  - neologism: คิดคำใหม่ขึ้นมาเอง

## ระดับการรู้สึกตัว (Conscious)

- Level of conscious (ระดับการรู้ตัว)
  1. confusion: สับสน มึนงง ไม่รับรู้วันเวลา สถานที่ บุคคล
  2. clouding: รับรู้และความคิดผิดปกติระดับปานกลาง
  3. stupor: ไม่ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้าง ไม่เคลื่อนไหว ไม่พูด แต่ยังรู้สึกตัว
  4. delirium: ระดับความรู้สึกตัวไม่สม่ำเสมอ
  5. coma: ไม่รู้สึกตัว





# การรับรู้เวลาสถานที่และบุคคล (Orientation)

ประเมินว่ามีการรับรู้เวลาสถานที่และบุคคลตรงตามความเป็นจริง หรือไม่

1. การรับรู้เวลา (Time) เช่น วันนี้วันอะไร เวลาอะไร

2. การรับรู้สถานที่ (Place)

เช่น ถามว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน

3. การรับรู้บุคคล (Person)

เช่น ถามว่าแพทย์ที่รักษาคุณชื่ออะไร ดิฉันเป็นใคร



## ความจำ (memory)

- Recent memory (ความจำระยะสั้น) ไม่เกิน 1-2 วัน  
เช่น ถามว่าเมื่อเช้าทานข้าวกับอะไร เมื่อวานใครมาเยี่ยม
- Remote memory (ความจำระยะยาว)  
เช่น ถามว่าตอนอนุบาลเรียนอยู่ที่ไหน เกิดที่ไหน
- Recall memory (ความจำทันทีทันใด)  
เช่น บอกสิ่งของ 3 อย่าง ให้ผู้ถูกประเมินจำไว้ อีก 5 นาทีมาถามใหม่  
ถ้าตอบได้ถูกต้อง ถือว่าความจำชนิดนี้ปกติ



## ความคิดเชิงนามธรรม (Abstract Thinking)

- **ความคิดเชิงนามธรรม(Abstract Thinking)** หมายถึง ความสามารถในการคิดแบบต่อยอด โดยไม่ได้ใช้เพียงแต่ข้อมูลจากประสาทสัมผัสเท่านั้น
- **ความคิดเชิงรูปธรรม(concrete thinking)** หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ใช้เพียงแต่ข้อมูลจากประสาทสัมผัสเท่านั้น

## ความคิดเชิงนามธรรม (Abstract Thinking)

- ความคิดเชิงนามธรรม(Abstract Thinking)
  - 1.บอกความแตกต่าง : กลางวันกับกลางคืน  
เด็กกับคนแคระ
  2. บอกความเหมือน : สัมกับกล้วย รถกับเรือ
  3. บอกความหมายของคำพังเพย



## ความคิดเชิงนามธรรม (Abstract Thinking)

ถามความหมายสุภาสิต “หนีเสือปะจระเข้แปลว่าอะไร”

- abstract thinking: “หนีสิ่งที่ร้ายไปเจอสิ่งที่ร้ายอีก”
- concrete thinking: “หนีเสือแล้วก็ไปเจอสัตว์ร้ายอีก”

ถามความหมายสุภาสิต “น้ำขึ้นให้รีบตักแปลว่าอะไร”

- abstract thinking: “เมื่อมีโอกาสให้รีบฉวยไว้”
- concrete thinking: “น้ำขึ้นตักง่ายต้องรีบ”



## ความคิดเชิงนามธรรม (Abstract Thinking)

ความเหมือนความสามารถในการจัดหมวดหมู่ (similarities): “สัมผัสกับกล้วยเหมือนกันอย่างไร” “รถกับเรือเหมือนกันอย่างไร” “ตากับหูเหมือนกันอย่างไร”

- **abstract thinking**: categorization “เป็นผลไม้เหมือนกัน” “เป็นพาหนะเหมือนกัน” “เป็นอวัยวะเหมือนกัน”
- **concrete thinking**: “กลมเหมือนกัน” “รถอยู่บนถนนเรืออยู่ในน้ำ” “ตาไว้ดูหูไว้ฟัง”





## สมาธิ (concentration)

- สังเกตจากกริยาท่าทาง การแสดงออก คำพูดโต้ตอบขณะ  
สัมภาษณ์
- ประเมินโดยให้ผู้ถูกประเมินลบเลข 100 ไปเรื่อยๆ ทีละ 7 หรือ  
20-3 (สามครั้ง) หรือสะกดคำถอยหลัง เช่น คำว่า “สะพาน”
- ผู้ป่วยสมองเสื่อม (dementia) หรือผู้ที่มีอาการทางจิตอย่าง  
เฉียบพลัน (acute psychosis) พบว่าสมาธิไม่ดี



## ความรู้ทั่วไปและความฉลาดรอบรู้ (General knowledge & intelligence)

- ประเมินได้จากการความสามารถในการใช้ภาษา
- คำถามต้องเหมาะสมกับระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ของผู้ถูกประเมิน
- คำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น นายกรัฐมนตรีคือใคร ตอนนี้ประเทศไทยกำลังประสบภัยธรรมชาติอะไร
- ถามคำถามเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวกับโรคที่เป็นหรือการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย เช่น คุณป่วยเป็นอะไร โรคที่เป็นต้องปฏิบัติตัวอย่างไร



# การรับรู้ (Perception)

เป็นการแปลความหมาย/ให้ความหมายในสิ่งที่มากระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน (ตา หู จมูก ลิ้น อวัยวะรับสัมผัส ทางกาย)

1. **Hallucination** (ประสาทหลอน) คือการรับรู้ผิดปกติ รู้สึกเองโดยไม่มีสิ่งเร้าจริง

2. **Illusion** (แปลภาพผิด) มีสิ่งเร้าจริง

# การรับรู้ (Perception)

1. Hallucination (ประสาทหลอน) คือการรับรู้ผิดปกติ ไม่มีสิ่งเร้าจริง

- \* visual hallucination : เห็นภาพหลอน
- \* auditory hallucination: หูแว่วได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน
- \* olfactory hallucination: การได้กลิ่นแปลกๆ ไปจากคนอื่น
- \* gustatory hallucination: การรับรสผิดปกติจากคนอื่น
- \* tactile hallucination: การรู้สึกมีอะไรมาไต่ตามตัว

2. illusion (การรับรู้สิ่งเร้าไม่ตรงตามความจริง) เช่น เห็นเชือกเป็นงู



## การตัดสินใจ (Judgment)

- ถ้ามคำถามที่ประเมินความสามารถในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ อาจถามแผนการให้นาคตของผู้ป่วยพร้อมเหตุผล  
เช่น “คุณจะทำยังไงถ้าไฟไหม้โรงหนังที่คุณกำลังดูอยู่”  
“คุณจะทำยังไงถ้าลืมกุญแจไว้ในบ้าน”  
“คุณจะทำอย่างไรถ้ายาหมดก่อนหมดนัดตรวจ”  
- การตัดสินใจไม่เหมาะสม (impaired judgment) พบในผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต (Psychosis), สมองเสื่อม, บุคลิกภาพผิดปกติ



## การรู้จักตนเอง (Insight)

- Insight (การรับรู้ตนเองตรงตามความเป็นจริง)  
เช่น รับรู้ว่าตนเองป่วยหรือมีปัญหา ประเมินจากการถามว่า  
คุณมาโรงพยาบาลด้วยอาการอะไร
- ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยทางจิตมักจะบอกว่าตนเองไม่ได้เจ็บป่วย  
(Poor insight)





# การสื่อสาร (Communication)

## 1. การพูด (speech)

- น้ำเสียง: อ่อนหวาน ตะโกน กระซิบ
- ความเร็วของการพูด: ช้า ช้ามาก เร็ว
- การตอบคำถาม: พูดช้า หยุดเป็นระยะ ๆ หยุดช่วงกลางประโยค
- แบบแผนการพูด: พูดอ้อมค้อม/ตรงไปตรงมา พูดชัดเจน/คลุมเครือ
- การสบตาผู้พูด (eye contact)
- พูดศัพท์ที่คนอื่นไม่เข้าใจ ใช้ภาษาหยาบคาย กำกวม เรื่องเพศ

## 2. กิริยาท่าทาง (gesture) เช่น กระตืบเท้า ชี้นิ้ว กำหมัด ก้าวร้าว

# แบบแผนความเครียดและการจัดการกับความเครียด (Stress & coping pattern)

- แบบแผนความเครียด: ประเมินสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเครียด บ่อยๆ เช่น ชีวิตประจำวัน หน้าที่การงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในชีวิต หรือความเจ็บป่วย ทนต่อความเครียดได้มากน้อยเพียงใด
- การจัดการกับความเครียด: ประเมินการจัดการกับความเครียดว่ามี ประสิทธิภาพหรือไม่
  - เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นมีการจัดการความเครียดอย่างไร
  - ใช้การจัดการกับความเครียดแบบใช้เหตุผล (problem-solving coping) หรือใช้อารมณ์ (emotional coping)



# มิติทางด้านสังคม (Social dimension)



## มิติทางด้านสังคม (Social dimension)

1. อัตมโนทัศน์
2. บทบาทและสัมพันธภาพ
3. บริบททางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

## อัตมโนทัศน์ (Self-concept)

- **Body image** (การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง)

คำถาม “คุณรู้สึกชอบส่วนไหนของร่างกายมากที่สุด”

“คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงส่วนไหนของร่างกาย”

- **Self-esteem** (ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง)

คำถาม “คุณรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในเรื่องอะไร”

“คุณภูมิใจอะไรในตนเองมากที่สุด”

“คุณคิดว่าตัวเองเป็นภาระกับใครหรือเปล่า”

ไม่ควรถามว่า “คุณรู้สึกตัว自己有คุณค่าหรือไม่”

# แบบแผนบทบาทและสัมพันธภาพ

## (Role & Relationship)

- แบบแผนบทบาท (Role): ประเมินการทำหน้าที่ในครอบครัว เช่น การเป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัว บางคนเป็นภรรยา ทำหน้าที่ดูแลลูกๆ ทำงานทั้งนอกบ้านและในบ้าน
- สัมพันธภาพ (Relationship): มีความสัมพันธ์กับครอบครัวเป็นอย่างไร ครอบครัวรักใคร่กันดีหรือไม่ สนุกกับใครมากที่สุด เวลามีปัญหาสมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือกันอย่างไร
- มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมอย่างไร มีเพื่อนสนิทหรือไม่ เวลามีปัญหาปรึกษาใคร มีเครือข่ายทางสังคม มากน้อยแค่ไหน ร่วมกิจกรรมของส่วนรวม/ชุมชนอะไรบ้าง



## ประวัติทางสังคม (Social history)

- ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมอย่างไร มีเครือข่ายทางสังคมมากน้อยแค่ไหน
- ควรสอบถามกิจกรรมชีวิตที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในสังคม เช่น การร่วมกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญในชีวิตการหย่าร้าง การเสียชีวิตของคนสำคัญ ต่าง ๆ ทางสังคม สัมพันธภาพ (Relationship



# มิติทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Dimension)





## ผลกระทบทางด้านจิตวิญญาณ

- การเปลี่ยนบทบาท เช่น จากหัวหน้าครอบครัวมาเป็นผู้ป่วย
- วิตกกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพกาย
  - ความเจ็บป่วย และ การไร้ความสามารถ
  - โรคที่เป็น ภาพลักษณะทางร่างกาย
  - ผลของการผ่าตัดและระยะเวลาในการฟื้นตัวหลังผ่าตัด



## แบบแผนคุณค่า ความเชื่อ และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Value-belief-spiritual pattern)

- ประเมินว่าผู้ป่วยมีจุดมุ่งหมายในชีวิตอย่างไร มีการวางแผนในอนาคตอย่างไร ชีวิตมีความหวังอย่างไร สิ่งที่มีความหมายในชีวิตคืออะไร ความสมบูรณ์ในชีวิต ความสุขของผู้ป่วยคือสิ่งใด
- สอบถามความเชื่อ ความศรัทธา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำนาจเหนือธรรมชาติ การปฏิบัติตามสิ่งที่เชื่อถือ



## แบบแผนคุณค่า ความเชื่อ และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Value-belief-spiritual pattern)

- นับถือศาสนาอะไร สนใจร่วมกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างน้อยเพียงใด เช่น การสวดมนต์มีความสำคัญและช่วยให้ลดความทุกข์ลงได้หรือไม่
- มีความเชื่อ/มีสิ่งใดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

## แบบแผนคุณค่า ความเชื่อ และสภาวะทางจิตวิญญาณ (Value-belief-spiritual pattern)

- ผู้ป่วยมีความคาดหวังกับความเจ็บป่วยของตนเองอย่างไร
- เรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจที่สุดในชีวิตคือเรื่องใด
- ใครหรือสิ่งใดทำให้ความทุกข์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร
- การปฏิบัติที่ทำให้ตนเองมีความสุขหรือเกิดกำลังใจเป็นอย่างไร



# ปัญหาทางจิตสังคมที่พบบ่อย

- วิตกกังวล (Anxiety)
- กลัว (Fear)
- โกรธ (Anger)
- เครียด (Stress)
- หหมดหวัง (Hopelessness)
- ว้าเหว่ (Loneliness)
- คุณค่าในตัวเองลดลง (low self-esteem)
- ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลง (Altered body image)



# ความต้องการของผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด

1. ความต้องการด้านข้อมูลข่าวสาร (Information needs) ความต้องการทราบข้อมูล เกี่ยวกับอาการ วิธีการผ่าตัด การรักษา ต้องการทราบช่องทางการ ติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในทีม สุขภาพ ต้องการพูดคุยกับแพทย์และพยาบาลคนเดิม ต้องการคำอธิบายที่ชัดเจน เข้าใจง่ายไม่ใช่ศัพท์ทางการแพทย์หรือพูดเร็วจนเกินไป

(Murola et al., 2007)



## ความต้องการของผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด

2. ความต้องการด้านอารมณ์ (Emotional needs) ความต้องการสนับสนุนทางด้าน อารมณ์ ต้องการให้มีคนคอย พุดคุย ปลอบโยน และให้กำลังใจ (Hobson et al., 2006) การให้กำลังใจ เอาใจใส่ การพุดคุยจากเจ้าหน้าที่ก่อน ได้รับการผ่าตัดทำให้ผู้ป่วยคลาย ความวิตกกังวล (ไมตรี ยอดแก้ว และคณะ ,2553)



## ความต้องการของผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด

3. ความต้องการด้านจิตวิญญาณ (Spiritual needs) เป็นความต้องการสนับสนุนทางด้าน จิตใจ เพื่อให้มีความหวังในการที่จะหายจากโรค การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อ เช่น การยึดมั่นในศาสนาหรือยึดความเชื่อของบุคคล โดยผู้ป่วยต้องการนำวัตถุหรือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมา ไว้กับผู้ป่วยและต้องการทราบเกี่ยวกับการทำพิธีทางศาสนาขณะที่ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล

(Gaglione, 1984; อัมภิชา นาไวย์, 2551)

## แนวทางการดูแลด้านจิตใจผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด

- ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยจากแฟ้มประวัติของผู้ป่วย พร้อมสอบถามข้อมูลผู้ป่วยจากพยาบาลที่หอผู้ป่วย
- สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ การให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการรักษาและการดูแลของทีมพยาบาลห้องผ่าตัด
- เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามข้อมูลที่ต้องการทราบเพิ่มเติม เพื่อคลายความวิตกกังวล และความกลัวต่อการผ่าตัด
- หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการดูแลให้เหมาะสม และตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละราย

## แนวทางการดูแลด้านจิตใจผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด

- การสัมภาษณ์ผู้ป่วยควรทำด้วยความนุ่มนวลและเป็นกันเอง ใช้คำพูดที่เหมาะสม เข้าใจได้ง่าย เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พูด บอกเล่าหรือแสดงความรู้สึกได้เต็มที่
- ถ้าในขณะที่ผู้ป่วยมีญาติหรือสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยควรกลับออกมาก่อนและเข้าไปเยี่ยมในภายหลัง ควรใช้เวลาญาติอยู่กับผู้ป่วยตามลำพัง
- เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยแสดงออกได้เต็มที่ และซักถามสิ่งที่ต้องการทราบได้อย่างเปิดเผย เพราะบางเรื่องผู้ป่วยอาจจะไม่ต้องการให้บุคคลในครอบครัวได้รับรู้

## แนวทางการดูแลด้านจิตใจผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด

- ให้ออกาสญาติหรือผู้ใกล้ชิดพูดคุยระบายความรู้สึก ชักถามข้อสงสัยที่เป็นประโยชน์ต่อการผ่าตัดและการรักษา
- ตรวจสอบความเข้าใจของผู้ป่วยและครอบครัว
- ให้ข้อมูลและความรู้แก่ญาติเกี่ยวกับการผ่าตัด วิธีปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด เพื่อดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง
- จัดให้ญาติได้พบกับแพทย์เจ้าของไข้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องได้ข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจ



- การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัดจากพยาบาลห้องผ่าตัดจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่น ใจที่จะได้พบกับผู้ที่คุ้นเคยขณะอยู่ในห้องผ่าตัด และรู้สึกมั่นใจในการช่วยเหลือจากพยาบาลใน ระยะที่อยู่ในห้องผ่าตัด รวมทั้งช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย

(ยุวดี วัดแก้ว และ อาภา เต็มเกาะ, 2551)



# การดูแลด้านจิตใจผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

- ดูแลเรื่องความวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการประกอบอาชีพที่ใช้แรงงาน และผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดมาก่อน
- พยาบาลควรมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความพร้อมด้านจิตใจก่อนได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น การจัดทำวีดีทัศน์ โปรแกรมคลายความวิตกกังวล
- ควรมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดให้ครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคและที่ได้รับการผ่าตัดชนิดต่างๆ เพราะอาจจะเกิดความวิตกกังวลที่แตกต่างกัน

# สิ่งที่พยาบาลห้องผ่าตัดควรหลีกเลี่ยงเมื่อไปเยี่ยม ผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด

1. ไม่บอกเล่าขั้นตอนการผ่าตัดละเอียดเกินไป จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกกลัวมากขึ้น
2. ไม่ขัดจังหวะการพูดหรือการแสดงความรู้สึกของผู้ป่วย การตัดบทสนทนาการแสดง สีหน้าหรือท่าทางไม่สนใจคำบอกเล่าหรือการแสดงออกของผู้ป่วย
3. ให้กำลังใจหรือสร้างความมั่นใจในทางที่ไม่ถูกต้อง
4. ใช้คำพูดที่ยุ่งยากสับสน ควรใช้คำพูดที่ง่ายได้ในความเหมาะสมกับระดับความรู้ ของผู้ป่วย

(สมนิตย์ สุวรรณรัตน์ โชติ, 2553)



## สิ่งที่พยาบาลห้องผ่าตัดควรปฏิบัติ

- แนะนำสภาพแวดล้อมในห้องผ่าตัด อธิบายให้ผู้ป่วยทราบเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยต้องเผชิญในห้องผ่าตัด มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
  - แจ้งข้อมูลลำดับการผ่าตัดของผู้ป่วยตามตารางการผ่าตัด ระยะเวลาโดยประมาณที่ไปรับผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด ระยะเวลาการผ่าตัด รวมทั้งเหตุการณ์และเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับในห้องผ่าตัดจนถึงเวลาทำการผ่าตัดและการพักผ่อนหลังผ่าตัด
  - แจ้งผู้ป่วยและครอบครัวทราบถึงช่องทางการติดต่อ วิธีการในการติดตามความคืบหน้าของการผ่าตัด บริเวณ/สถานที่พักรอสำหรับครอบครัวขณะผู้ป่วยทำหัตถการในห้องผ่าตัด



## สิ่งที่พยาบาลห้องผ่าตัดควรปฏิบัติ

- ควรแจ้งวิธีการระงับความรู้สึกในขณะผ่าตัดและให้ความรู้โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแก่ผู้ป่วยรวม
- ตอบคำถามและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการระงับความรู้สึกวิธีต่างๆ ของผู้ป่วย
- แจ้งให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับการเย็บมก่อนผ่าตัดโดยทีมวิสัญญี เพื่อประเมินความเหมาะสมและตัดสินใจเลือกวิธีการระงับความรู้สึก ร่วมกับทีมวิสัญญีอีกครั้ง



# สิ่งที่พยาบาลห้องผ่าตัดควรปฏิบัติ

- สนับสนุนด้านจิตใจและรับฟังความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัว
- เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึก ความปรารถนาหรือความคาดหวังเกี่ยวกับการรักษา
- หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ทำให้ผู้ป่วยหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลต่อการฟื้นฟูของผู้ป่วย

## สิ่งที่พยาบาลห้องผ่าตัดควรปฏิบัติ

- เมื่อสิ้นสุดการสนทนาควรสังเกตปฏิกิริยาของผู้ป่วย เช่น การเปลี่ยนแปลงสีหน้า อารมณ์ของผู้ป่วย และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความต้องการของผู้ป่วย
- ส่งเสริมความมั่นใจด้านการเผชิญการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับสถานการณ์ของการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
- ควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้การคิดบวก ยึดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
- เป็นผู้ฟังที่ดีให้ความสำคัญต่อการฟังและใช้เทคนิคการถามเพื่อสะท้อนความรู้สึของผู้ป่วย

## สิ่งที่พยาบาลห้องผ่าตัดควรปฏิบัติ

- ใช้คำพูดที่สุภาพและนุ่มนวล รวมทั้งควรแสดงออกถึงความเข้าใจและเห็นใจผู้ป่วยขณะสนทนา
- ขออนุญาตก่อนให้การพยาบาล เป็นการแสดงการ respect ผู้ป่วย
- ไม่พูดขัดจังหวะหรือพูดตำหนิ เพราะจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอาย/รู้สึกผิด
- ให้ครอบครัวและบุคคลที่ผู้ป่วยไว้วางใจมีส่วนร่วมขณะให้การพยาบาล
- ให้กำลังใจอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้ค้นหาสาเหตุของปัญหา หรือแสดงความรู้สึก





## สิ่งที่พยาบาลห้องผ่าตัดควรปฏิบัติ

- รับฟังปัญหาและความวิตกกังวลทั้งของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดและบุคคลในครอบครัว
- สนทนากับผู้ป่วยอย่างเป็นกันเองเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัยและเกิดความไว้วางใจในขณะบอกเล่าข้อมูล
- สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบการดูแลของทีมผ่าตัดและให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เข้ารับบริการในห้องผ่าตัด



# สรุป

- ภาวะสุขภาพ เป็นผลรวมของการทำงานผสมผสานกันระหว่างองค์ประกอบทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ จึงจำเป็นต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้าน
- การประเมินภาวะจิตสังคม เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพยาบาลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัญหาหรือความต้องการของผู้ป่วย นำไปวางแผนให้การพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย





# Thank you for your attention



Pasitta Ondee

E-mail: [pasitta.ond@mahidol.ac.th](mailto:pasitta.ond@mahidol.ac.th)